Boletín Epidemiológico N° 25 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

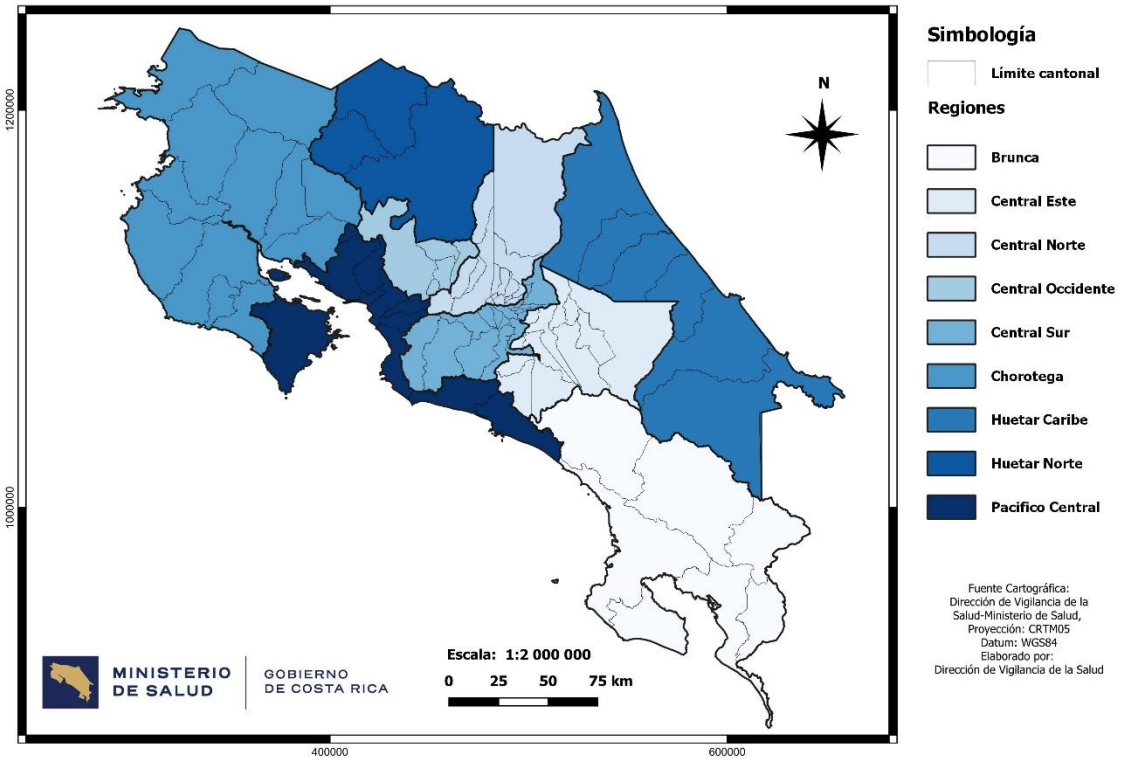
Ministerio de Salud

11 de julio de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 26 .. 9
Malaria 11
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 19
Meningitis 34
Infecciones de transmisión sexual 38
Miasis por gusano barrenador en humanos 47
Incidencia De Obesidad en Costa Rica. 2024 54

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 26 del año 2025 se notifican **2387 casos** de dengue, de estos 27 acumulados notificados con signos de alarma.

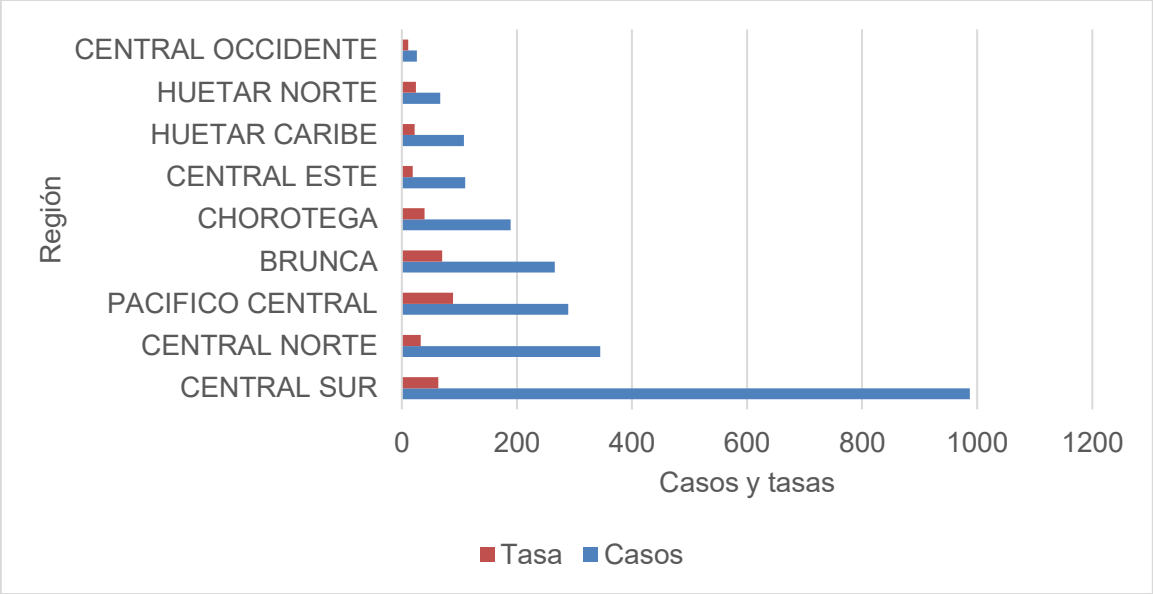
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 987 casos y la tasa más alta en la Pacífico Central 89,0/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 26, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	987	63,6
Central Norte	345	32,6
Pacifico Central	289	89,0
Brunca	266	70,2
Chorotega	189	39,6
Central Este	110	19,0
Huetar Caribe	108	22,3
Huetar Norte	67	24,6
Central Occidente	26	11,3
Total	2387	44,6

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 26, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

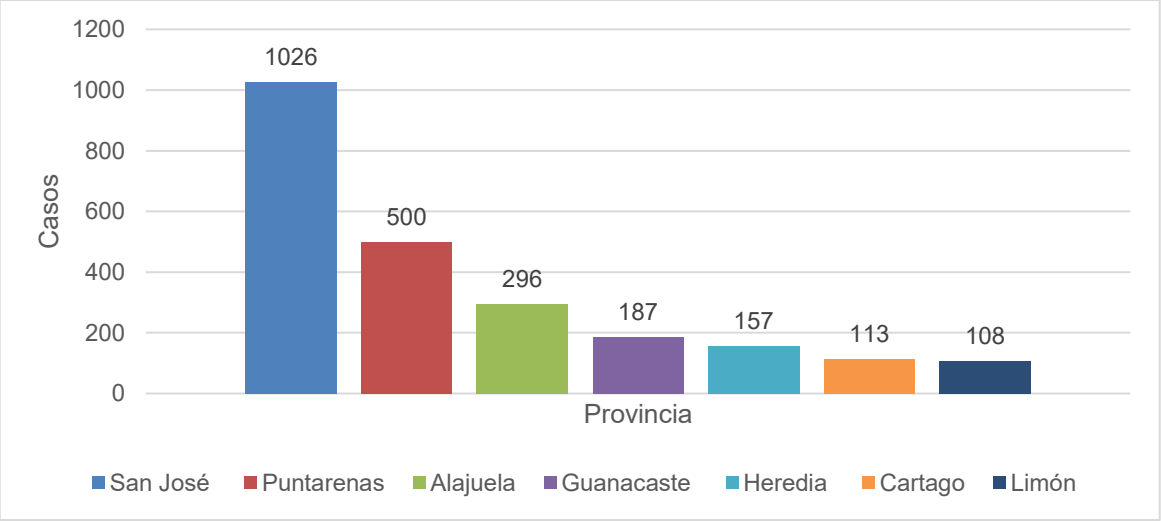
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	1026	59,8	525	60,8	501	58,7
Puntarenas	500	94,8	217	83,6	283	105,6
Alajuela	296	27,1	152	28,1	144	26,1
Guanacaste	187	44,5	82	39,6	105	49,3
Heredia	157	28,1	77	27,6	80	28,5
Cartago	113	20,3	53	19,1	60	21,5
Limón	108	22,3	44	18,7	64	25,8
Total	**2387**	**44,6**	**1150**	**43,2**	**1237**	**45,9**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 26, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 26 son: San José 628 casos, Alajuela 140 casos, Puntarenas 101 casos, Esparza 101 casos y Sarapiquí 97 casos.

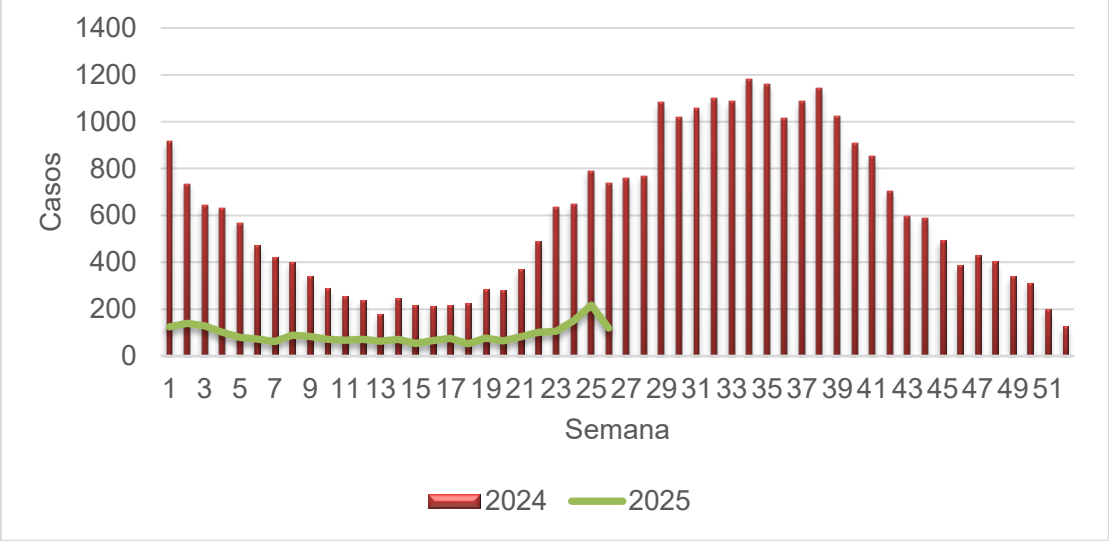
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 26, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	628	175,4
201: Alajuela	140	42,1
601: Puntarenas	101	67,7
602: Esparza	101	247,8
410: Sarapiquí	97	102,5
110: Alajuelita	86	85,3
605: Osa	75	236,7
610: Corredores	72	130,9
103: Desamparados	64	25,1
607: Golfito	58	121,1
210: San Carlos	56	26,1
109: Santa Ana	51	79,9
119: Pérez Zeledón	42	29,3
609: Parrita	39	176,4
502: Nicoya	37	62,6

305: Turrialba	35	47,8
702: Pococí	33	20,6
510: La Cruz	28	94,9
113: Tibás	26	29,6
506: Cañas	26	75,6

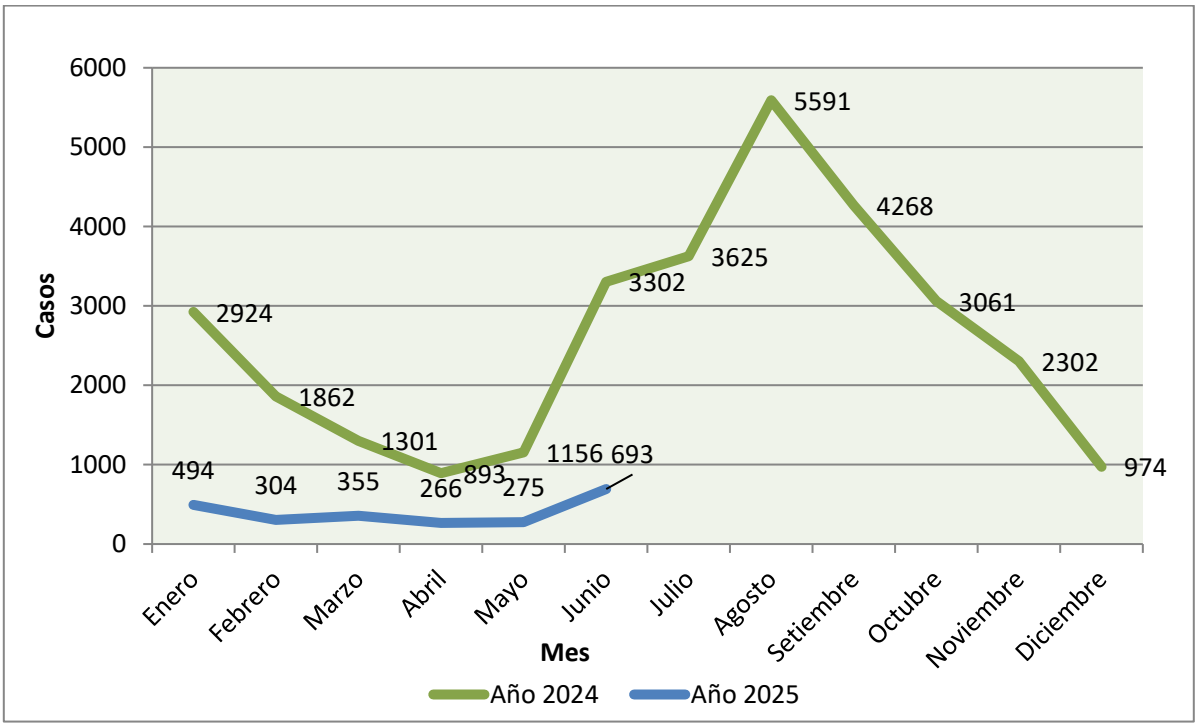
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 26, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 4.
Costa Rica: casos de dengue notificados por mes, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 26 del 2024 se reportó un total de 11438 casos de dengue, para este 2025 se reportan 2387 para un descenso del 77%.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 26, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	125
2	735	139
3	641	129
4	631	101
5	568	80
6	472	73
7	421	62
8	401	89
9	340	83
10	289	71
11	256	67
12	238	71

13	178	63
14	247	71
15	216	53
16	214	66
17	216	76
18	223	52
19	285	77
20	280	64
21	368	82
22	489	101
23	636	106
24	648	150
25	790	217
26	739	119
Total	**11438**	**2387**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

La CCSS no reporta internamientos por dengue al 7 de julio del 2025.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 26

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la SE_26 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 26

	Total
Viviendas visitadas	**12.961**
Viviendas positivas	**914**
Depósitos tratados	**45.635**
Depósitos eliminados	**73.143**
Depósitos positivos	**1.551**
Viviendas fumigadas	**14.474**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la Semana Epidemiológica 1 a la 26.

	Total
Viviendas visitadas	**325.003**
Viviendas positivas	**14.218**
Depósitos tratados	**1.198.954**
Depósitos eliminados	**877.903**
Depósitos positivos	**24.516**
Viviendas fumigadas	**307.535**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 26, se observa una disminución progresiva en el número de casos de transmisión local de malaria a lo largo de los últimos tres años. En el año 2023, se registraron 354 casos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 155 casos, lo que representa una disminución del 56%. En lo que va del año 2025, se han reportado 6 casos, lo que equivale a una reducción del 98% en comparación con el mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, en lo que va del año 2025 se ha 1 caso introducido en Santa Rosa de Pocosol y se han detectado 14 casos importados de malaria, siento el 79% *P. vivax* (N=11) y 21% *P.falciparum* (N=3) cuya transmisión ocurrió fuera del país. Estos casos fueron identificados en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles. Las personas afectadas se desempeñan principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas y coligalleros, y además personas que se encuentran en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, ruta migratoria desde América del Sur y de retorno desde México y Gabón, África.

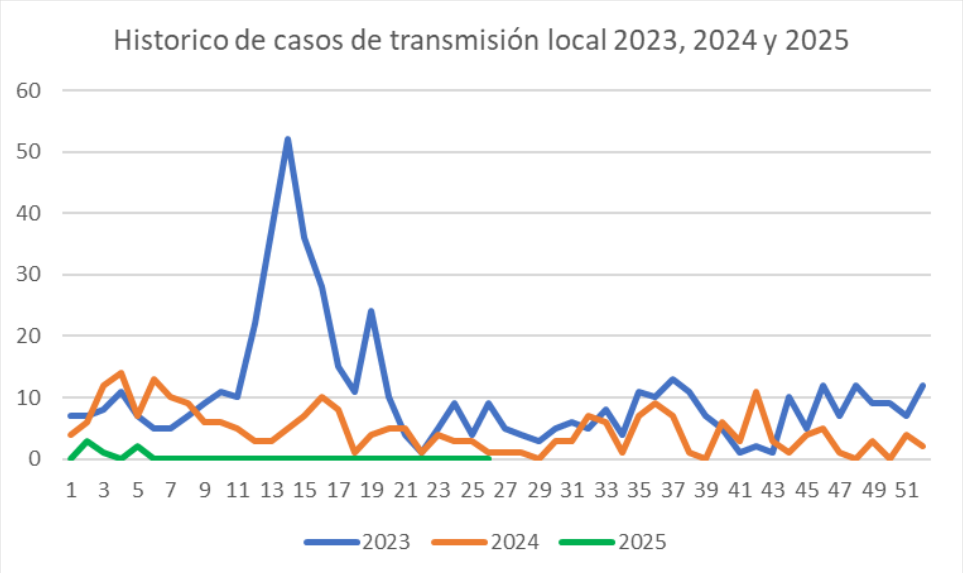
Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE26.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0

10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0
23	5	4	0
24	9	3	0
25	4	3	0
26	9	1	0
Total	**354**	**155**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 26.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.
A semana epidemiológica 26, se registraron 69.461 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 32.934, referirse a la tabla 2.
    - **Colaboradores Voluntarios**: 743
    - **Inspectores de Salud**: 32.191

- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 36.527, referirse al gráfico 3.
    - **Gotas gruesas**: 6.634
    - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 29.893
    - **PCR**: 357

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

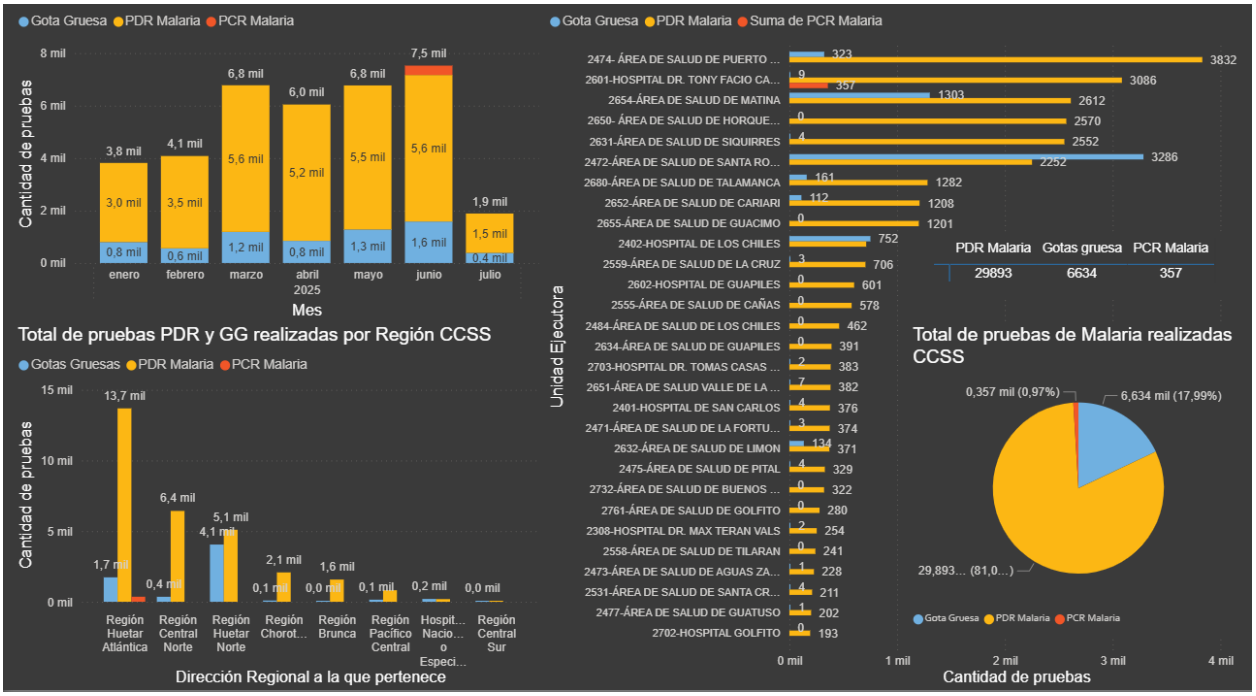
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	12679	55
Central Norte	152	28
Chorotega	4628	137
Huetar Caribe	5960	202
Huetar Norte	7557	290
Pacífico Central	1214	31
Total	32191	743

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región

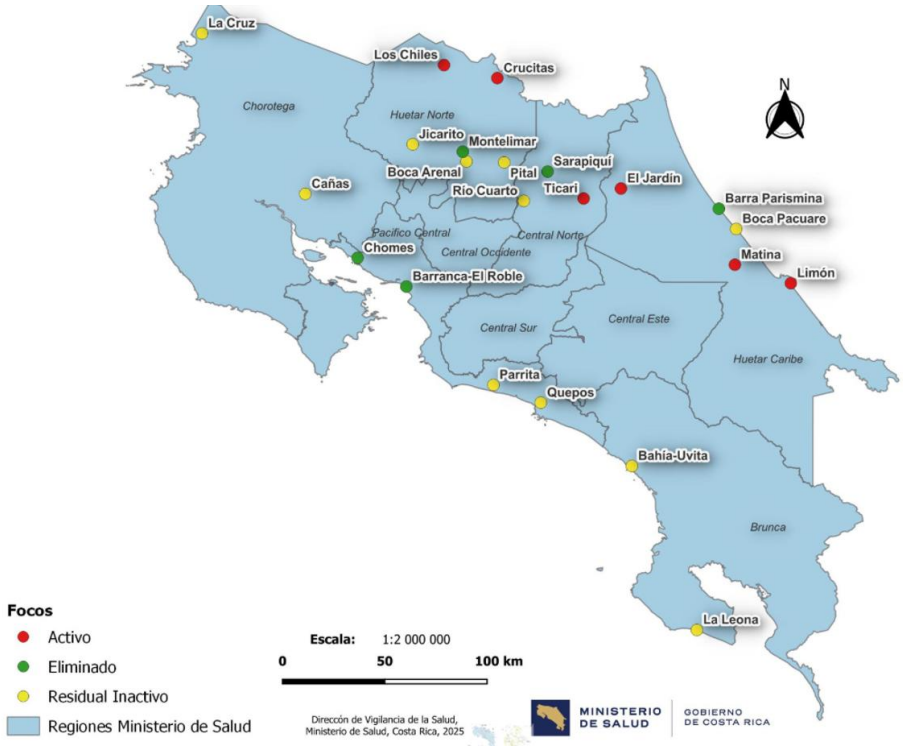
Región	Suma de Total de PDR realizadas	Suma de Total de Gotas gruesas analizadas
Región Huetar Atlántica	13686	1730
Región Central Norte	6429	353
Región Huetar Norte	5096	4051
Región Chorotega	2078	89
Región Brunca	1573	31
Región Pacífico Central	819	148
Hospitales Nacionales o Especializados	189	201
Región Central Sur	23	31
Total general	**29893**	**6634**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 4.
Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

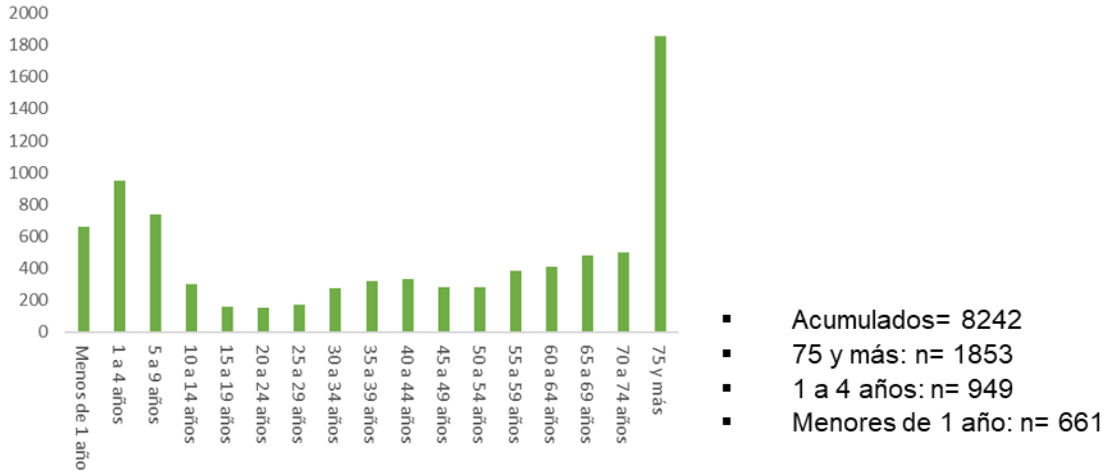
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 26 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 26 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 26 son un total de 8242.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

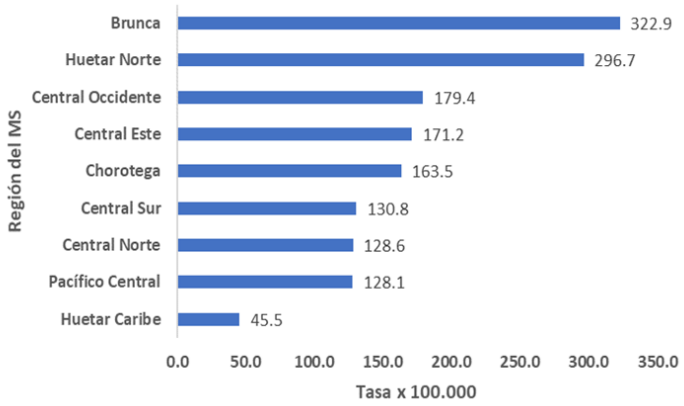
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 26, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 26, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

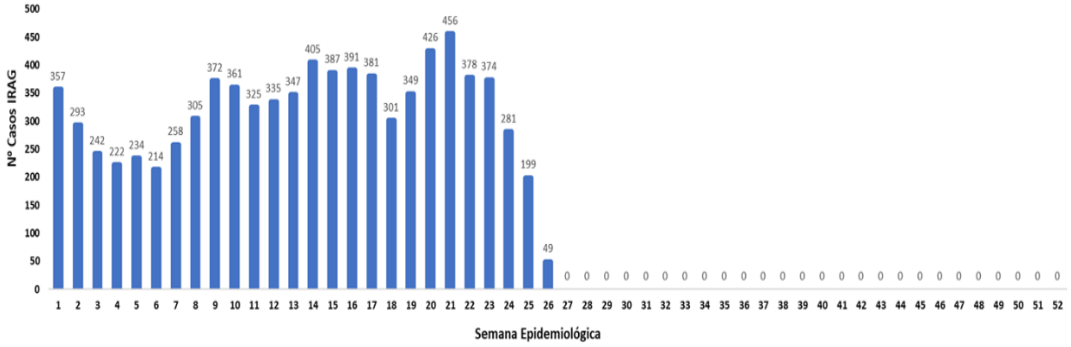
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 26 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 26 del año 2025.

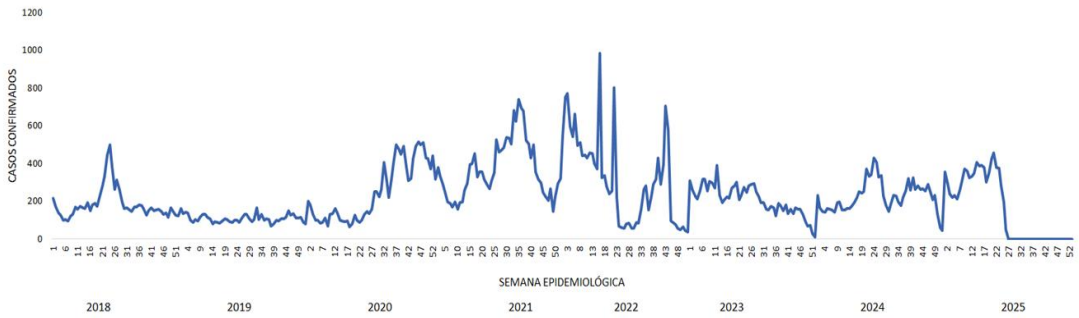
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 26, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

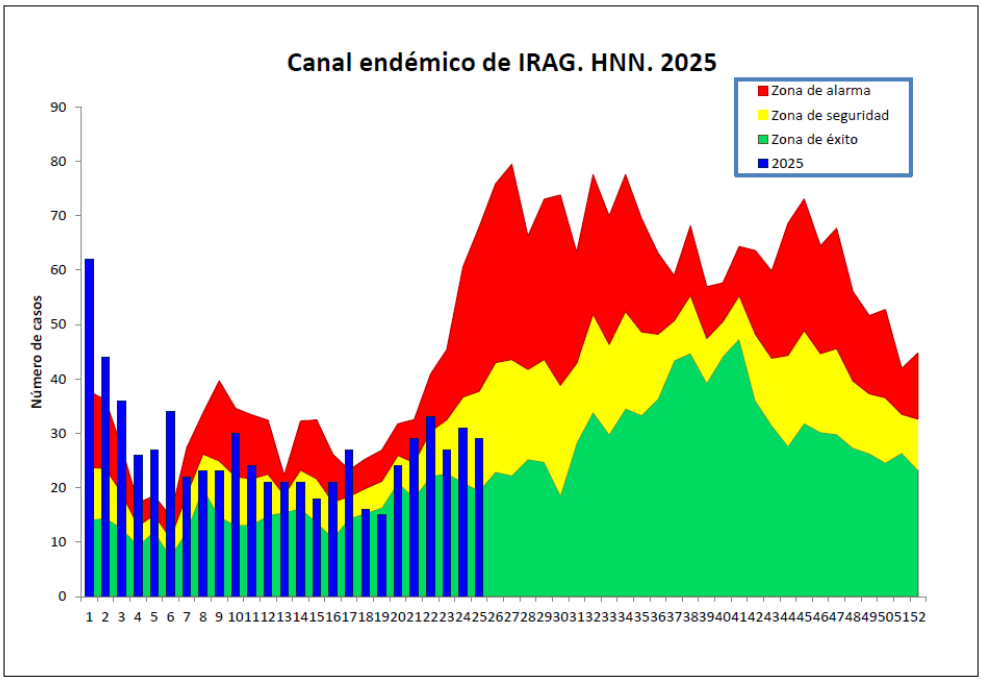
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-25 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de seguridad, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

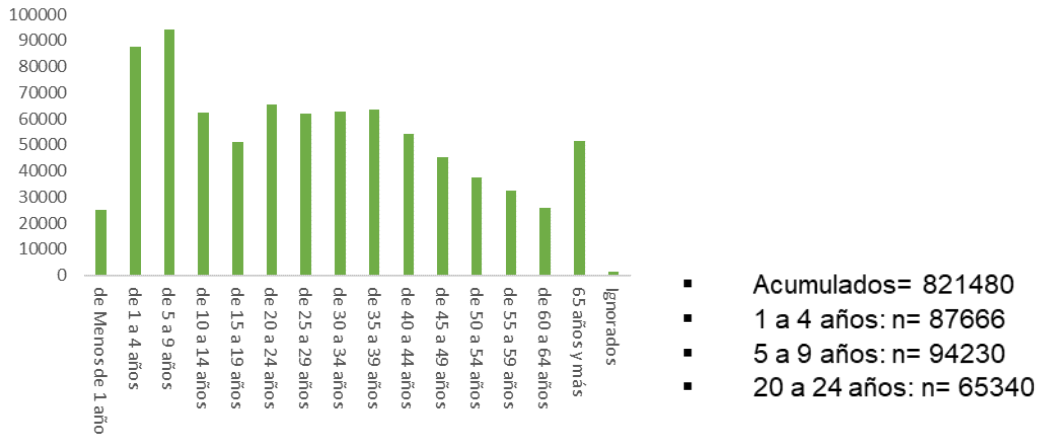


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 26 son 821480.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

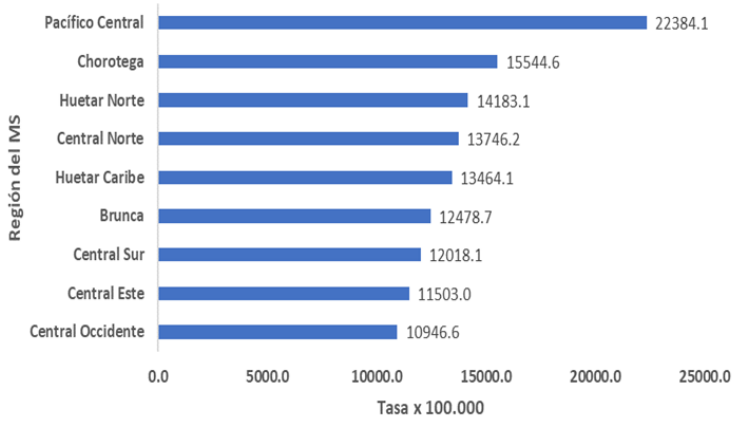
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 26, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 26, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, Chorotega y Huetar Norte. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

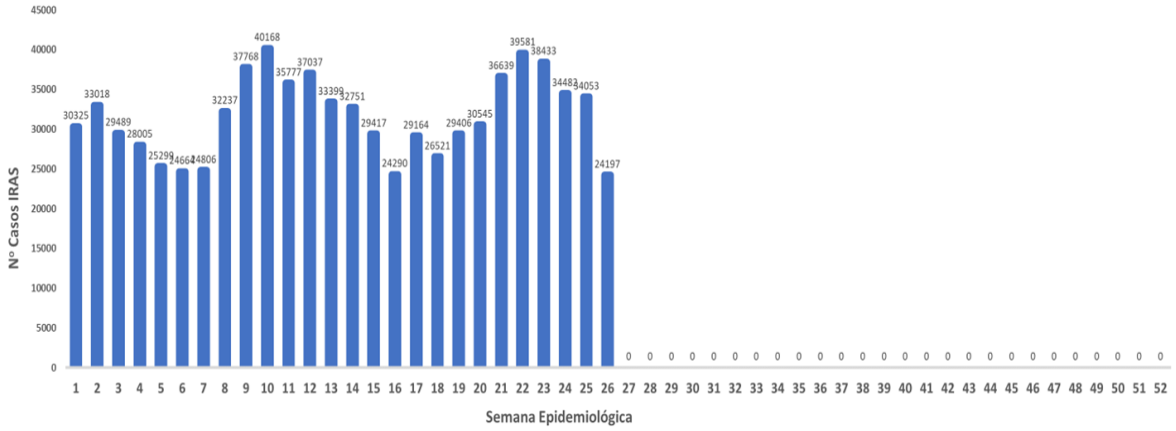
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 26 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 26 semanas epidemiológicas del año 2025.

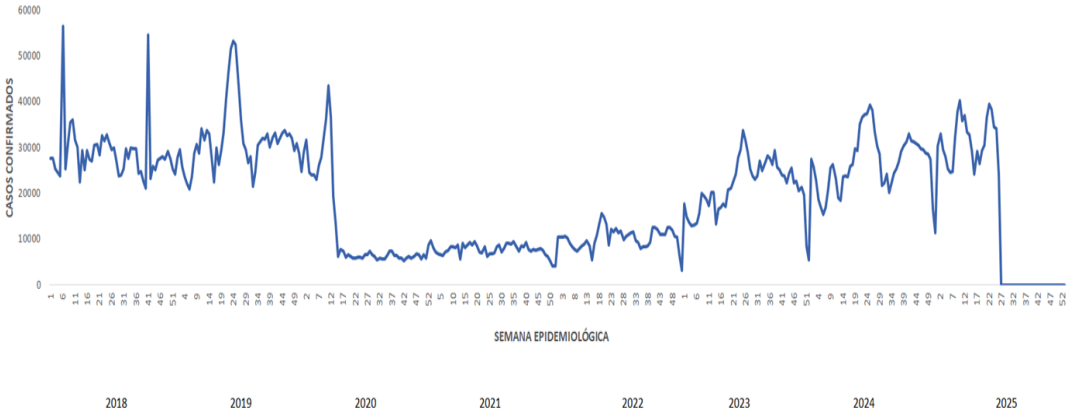
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 26, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

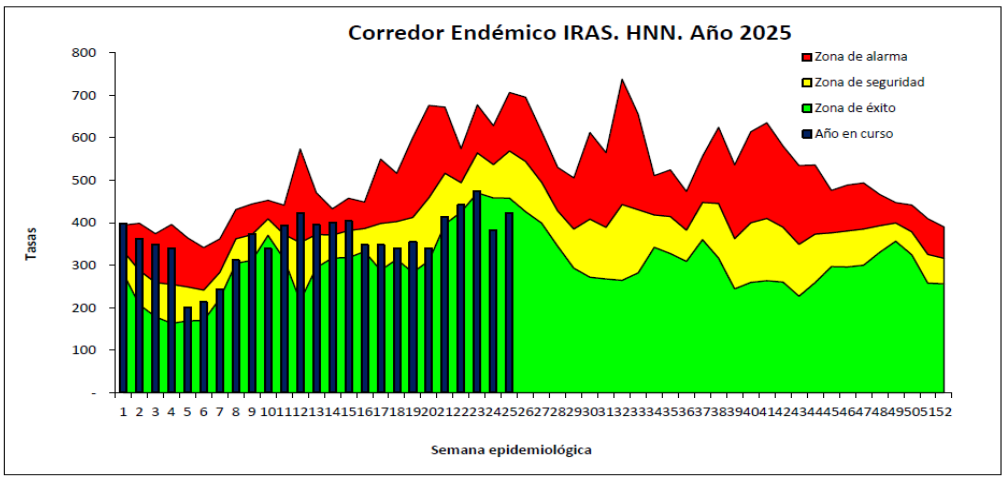
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 25 se encuentran en la zona de éxito actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

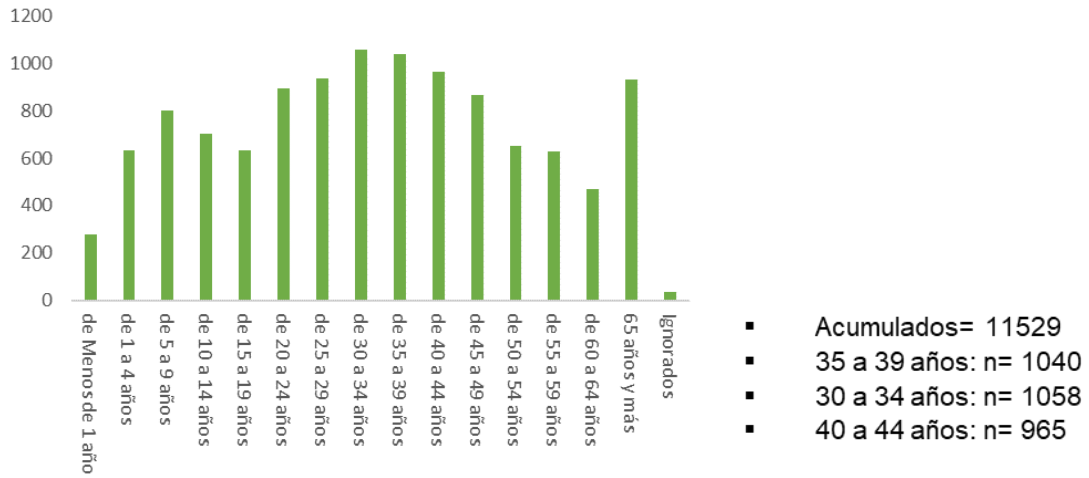


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 26 son n= 11529.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

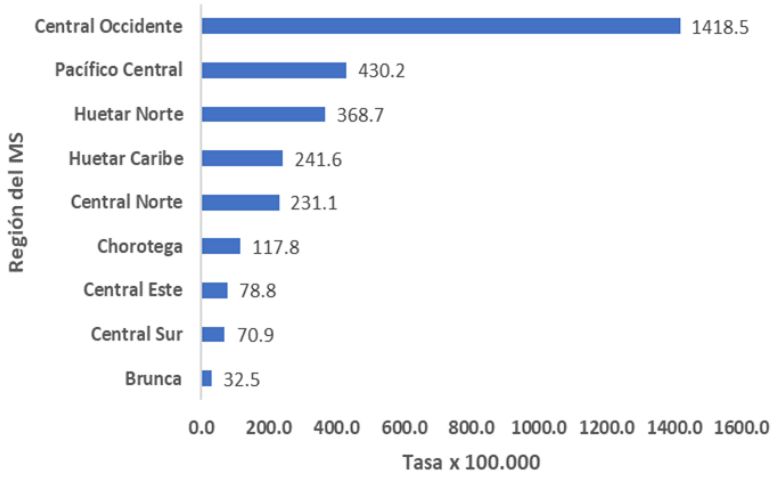
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 26, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 26, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 26 del 2025, en Costa Rica.

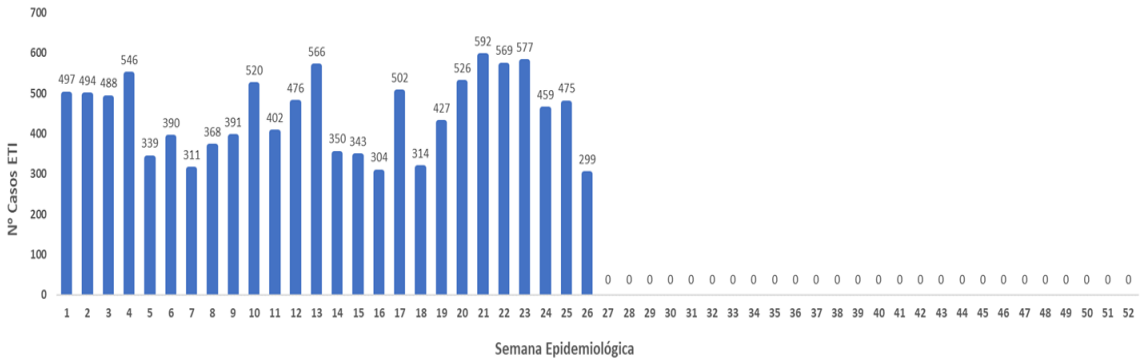


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025

.

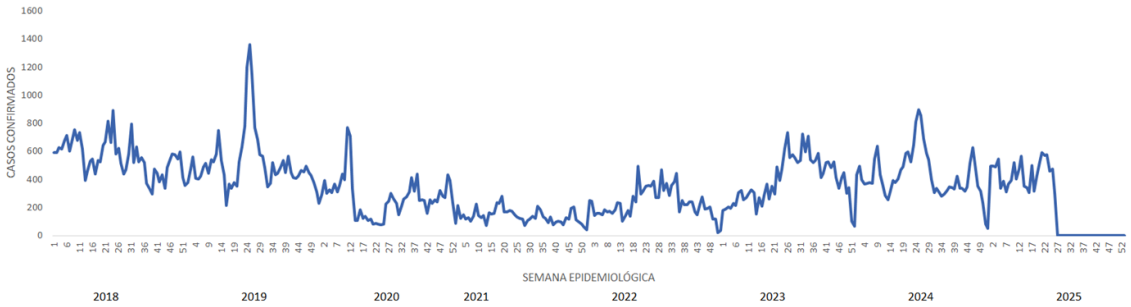
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 26, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

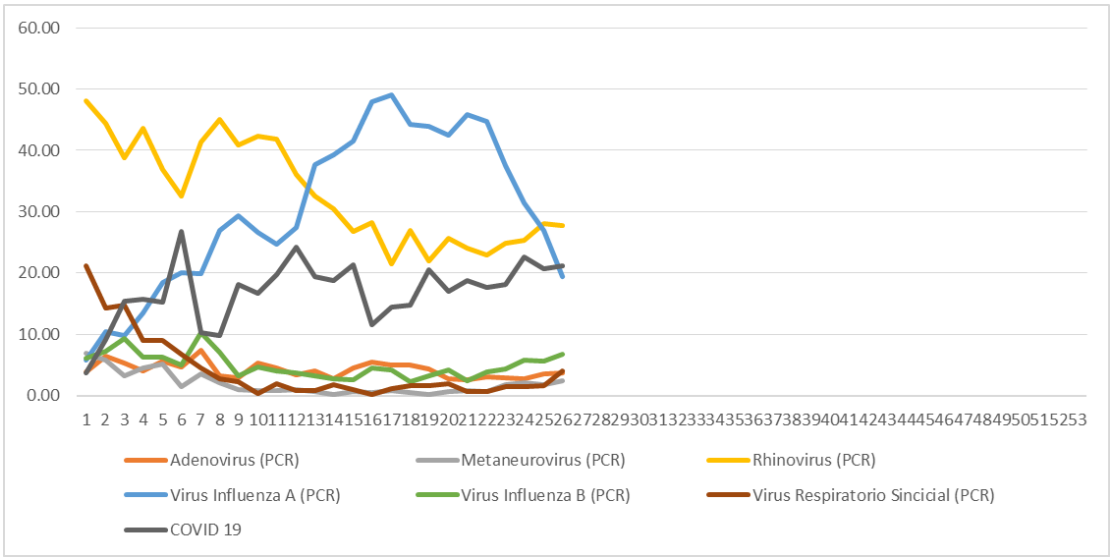
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 26; para la SE-26, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del Covid-19 y finalmente el virus de la Influenza A está en tercer lugar de circulación.

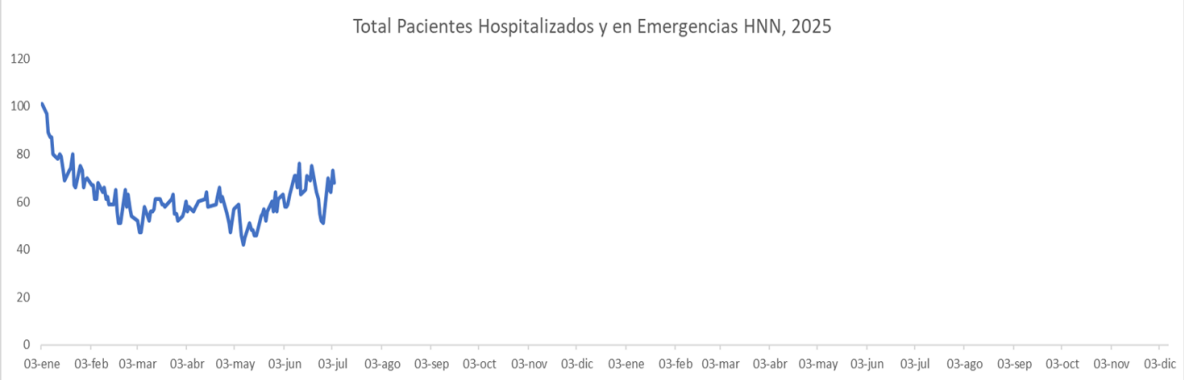
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 26 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 28 del año 2025 es la siguiente:
Al 7 de julio del año en curso, correspondiente a la semana 28, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 65, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 97%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 28 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



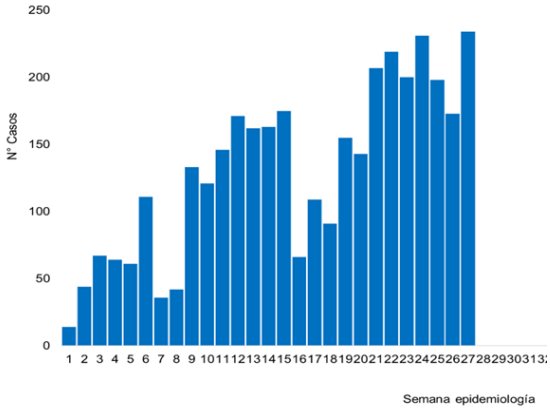
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 8242 casos a la semana 26.
- IRAS con 821480 casos a la semana 26.
- ETI con 11529 casos reportados a la semana 26.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 97%
- En SE-26, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del Covid-19 y en tercer lugar circula el Virus de Influenza A.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 27, se reportaron un total de 234 casos confirmados, lo que representa un aumento del 35.26% con respecto a la SE-26 del año 2025 que presentó 173 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

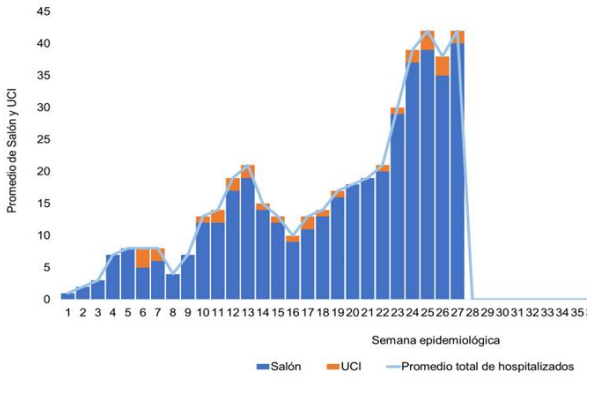


SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	91
19	155
20	143
21	207
22	219
23	200
24	231
25	198
26	173
27	234

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 27, se reportó un promedio total de 42 hospitalizados, lo que representa un aumento del 10.5% con respecto a la SE-26 del año 2025 donde se registraron 38 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

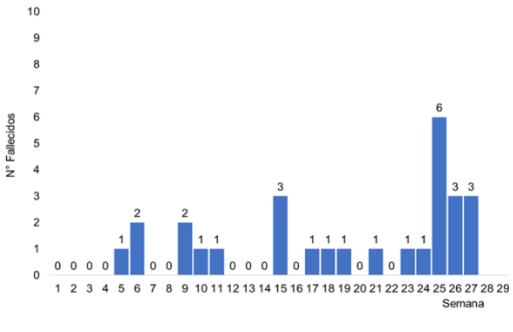


SE	Salón	UCI	Promedio total de hospitalizados
1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30
24	37	2	39
25	39	3	42
26	35	3	38
27	40	2	42

Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 27, hubo 3 fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

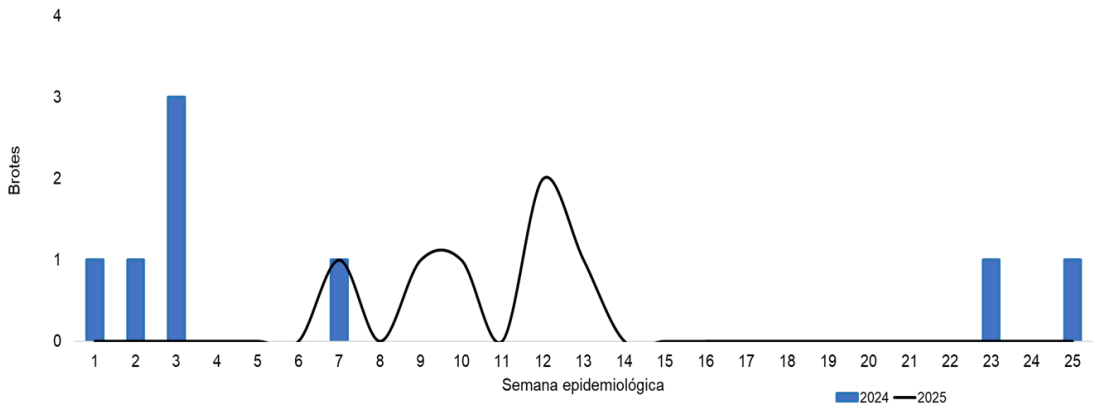


Semanas	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1
24	1
25	6
26	3
27	3

Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 25 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

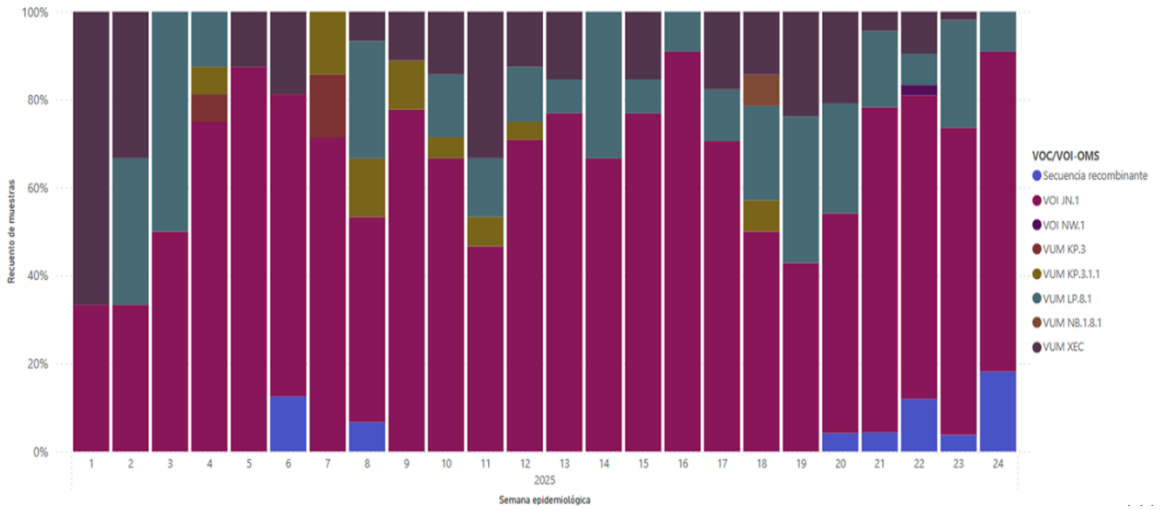
Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025.

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 9 de julio del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.

Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-24 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 9 de julio del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 24 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1-24 del 2025

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	14	3.49
VOI JN.1	265	66.08
VOI NW.1	1	0.25
VUM KP.3	2	0.50
VUM KP.3.1.1	10	2.49
VUM LP.8.1	62	15.46
VUM NB.1.8.1	1	0.25
VUM XEC	46	11.47
Total	401	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 9 de julio 2025

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

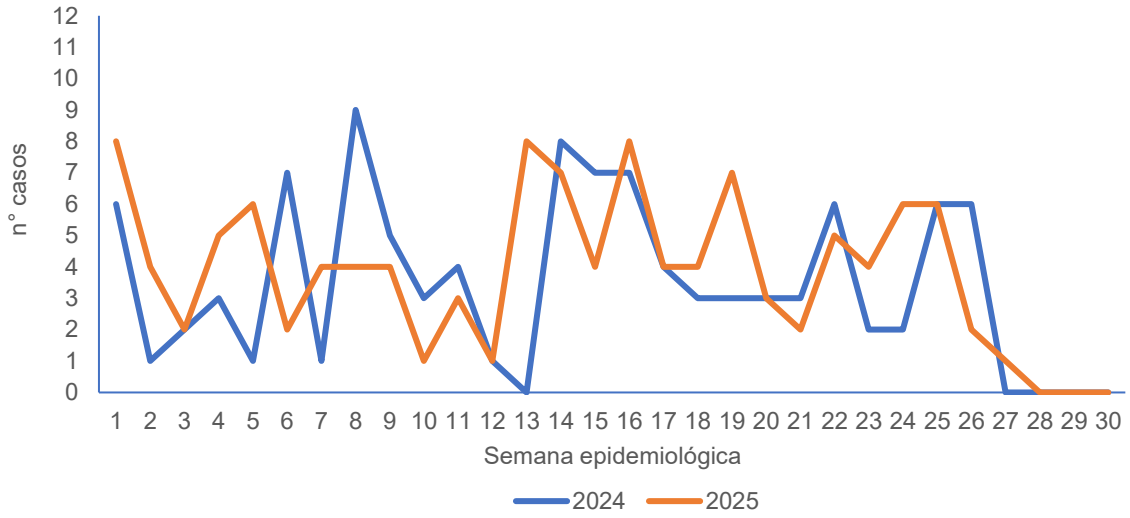
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, hasta la semana epidemiológica 26 del año 2025, se han registrado 115 casos sospechosos de meningitis reportados mediante boleta VE01, lo que representa una tasa de incidencia de 2,1 por cada 100.000 habitantes. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 103 casos, se observa un incremento del 11,6%.
Durante este periodo, se confirmó un evento de transmisión intrafamiliar limitado a dos personas en el cantón de Alajuelita. Las autoridades de salud actuaron de manera oportuna, implementando de inmediato las medidas de contención establecidas en el protocolo nacional para vigilancia y control de las meningitis bacterianas con el objetivo de prevenir una mayor propagación.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la región Central Este notificó el 26,1% de los casos (30/115), seguido de la Central Sur con el 24,3% (28/115) y Central Norte con el 20,9% (24/115).

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 26, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Turrubares de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 13,1, seguido de Dota también de la provincia de San José con 12,2 y Cartago con 10,1.

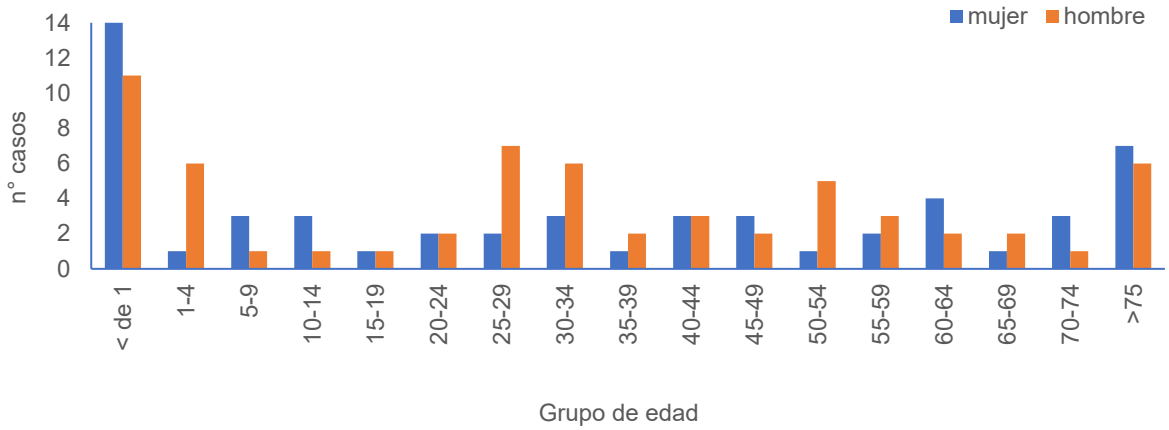
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 26, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

cantón	casos	tasa
Turrubares	1	13,8
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Leon Cortes	1	7,0
Santa Cruz	5	6,7
Alvarado	1	6,3
Sarapiqui	6	6,3
Jimenez	1	6,1
Tarrazu	1	5,2
Liberia	4	4,8
Santa Barbara	2	4,4
Valverde Vega	1	4,3
Perez Zeledon	6	4,2
Talamanca	2	4,2
Flores	1	3,8
La Union	4	3,4
Moravia	2	3,1
Aserri	2	3,0
Goicoechea	4	2,8
Quepos	1	2,8
Turrialba	2	2,7
Esparza	1	2,5
Alajuela	8	2,4
Palmares	1	2,3
El Guarco	1	2,1
San Jose	7	2,0
Desamparados	5	2,0
Alajuelita	2	2,0
Grecia	2	2,0
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
Limon	2	2,0
San Rafael	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Santa Ana	1	1,6
Montes de Oca	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
San Carlos	1	0,5

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 46,9% de los casos (55/115) son mujeres y el 53,0% (61/115) son hombres. El 21,7% de los casos (25/115) son menores de 1 año.

Figura 3.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 26, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

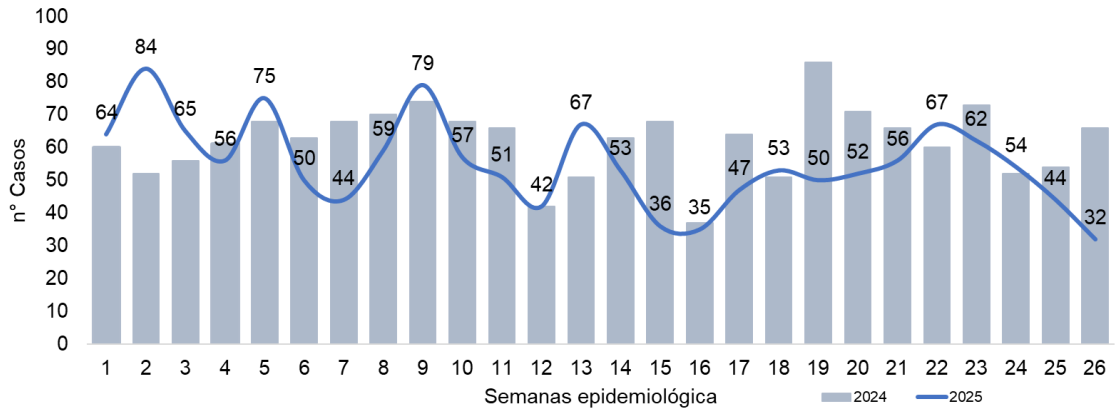
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 26 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, y herpes virus.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 26 semanas del 2025, se han notificado 1435 casos con una tasa 26,8 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1610 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 11,0% con 176 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en las primeras 26 semanas del año, se reportaron en los hombres un 56,72% de los casos (814/1435), con una tasa de 30,2 por 100 000 habitantes, las mujeres presentan el 43,28% de los casos (621/1435), con una tasa de 23,3 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son: 20 a 64 años con 79,79% (1145/1435), seguidos por el de mayores de 65 años con 10.1% con (145/1435), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,8% con (69/1435), y los menores de 1 año con el 5,1% de los casos (73/1435), los menores de 10 a 14 años un caso, grupo de 1 a 4 años dos casos y el grupo de 5 a 9 años sin casos, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 26 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	73	108,1
de 1 a 4 años	2	0,7
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	69	18,2
de 20 a 24 años	175	45,0
de 25 a 29 años	221	52,0
de 30 a 34 años	220	49,5
de 35 a 39 años	153	33,8
de 40 a 44 años	120	29,4
de 45 a 49 años	95	27,4
de 50 a 54 años	56	19,1
de 55 a 59 años	51	18,3
de 60 a 64 años	54	20,6
de 65 a 69 años	44	20,6
de 70 a 74 años	39	25,0
75 años y más	62	29,4
Total	1435	26,80

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2. Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos y tasas (Tasa p/100.000 habitantes), semana 26 del 2025

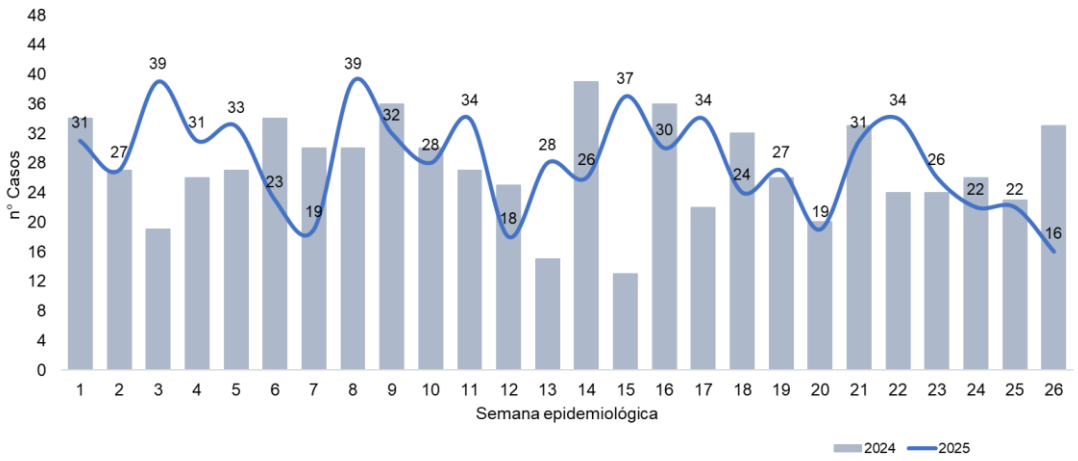
Provincias	Nº	Tasa
San José	512	29,8
Alajuela	205	18,8
Cartago	189	34,0
Heredia	104	18,6
Guanacaste	77	18,3
Puntarenas	108	20,5
Limón	240	49,6
Total	1435	26,80

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es prevenible y tratable. Esta enfermedad se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país. En las primeras 26 semanas del 2025, se han notificado 730 casos con una tasa de 13,6 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 711 casos, lo que representa para el año 2025 un ascenso del 2,67 % con 19 casos más. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 25 semanas del año en curso reporta en los hombres un 84,11% (614/730), con una tasa de 22,8 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 15,89% (116/730), con una tasa de 4,4 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,19% (600/730), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,52% (106/730), y los mayores de 65 años con 2,19% (16/730), los menores de 1 año un caso y los de 1 a 14 años con siete casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 26 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	2	0,7
5 a 9	1	0,3
10 a 14	4	1,1
15 a 19	106	27,9
20 a 24	179	46,1
25 a 29	143	33,6
30 a 34	105	23,6
35 a 39	74	16,3
40 a 44	37	9,1
45 a 49	16	4,6
50 a 54	22	7,5
55 a 59	16	5,7
60 a 64	8	3,1
65 a 69	10	4,7
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	3	1,4
Total	730	13,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 26 del 2025

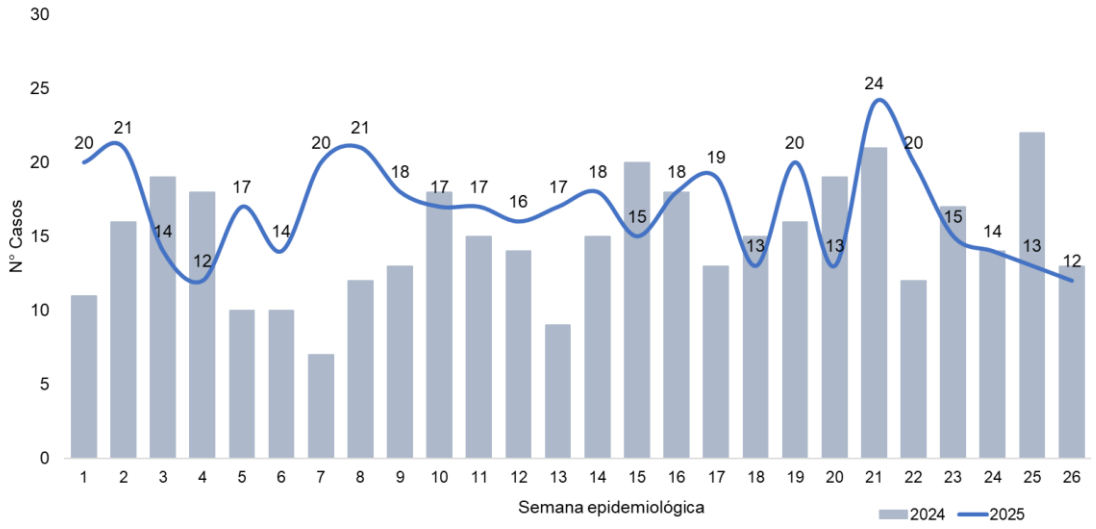
Provincias	Casos	Tasa
San José	269	15,7
Alajuela	107	9,8
Cartago	63	11,3
Heredia	63	11,3
Guanacaste	40	9,5
Puntarenas	82	15,5
Limón	106	21,9
Total	730	13,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 26 semanas del año en curso, con 438 casos con una tasa de 8,2 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 387 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 13,0%, con 51 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 26 semanas del año se ha notificado en mujeres un 67,81% de los casos (297/438), con una tasa de 11,2 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 32,19% de los casos con (141/438), con una tasa de 5,2 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 81,74% (358/438), seguidos por 15 a 19 años con 13,01% (57/438), mayores de 65 años con 4,11% con (18/438), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con cuatro casos, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 26 del 2025

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	4	1,1
15 a 19	57	15,0
20 a 24	82	21,1
25 a 29	64	15,1
30 a 34	60	13,5
35 a 39	53	11,7
40 a 44	32	7,8
45 a 49	26	7,5
50 a 54	10	3,4
55 a 59	15	5,4
60 a 64	16	6,1
65 a 69	11	5,1
70 a 74	5	3,2
Más 75 años	2	0,9
Total	438	8,20

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 26 del 2025

Provincias	Casos	Tasa
San José	212	12,3
Alajuela	46	4,2
Cartago	30	5,4
Heredia	30	5,4
Guanacaste	10	2,4
Puntarenas	54	10,2
Limón	56	11,6
Total	438	8,20

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

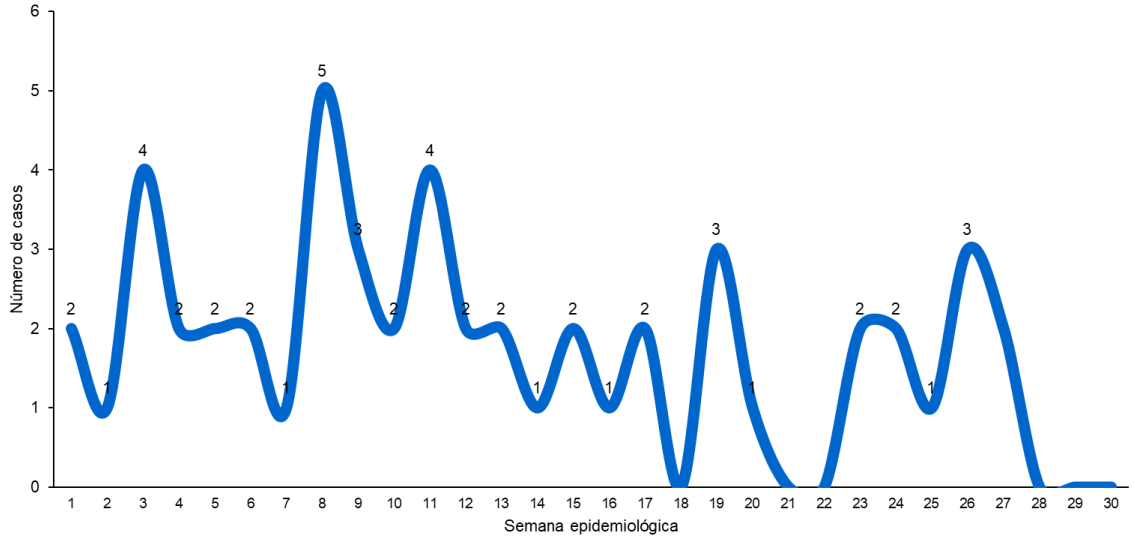
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 27 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 27, se tienen los siguientes datos:

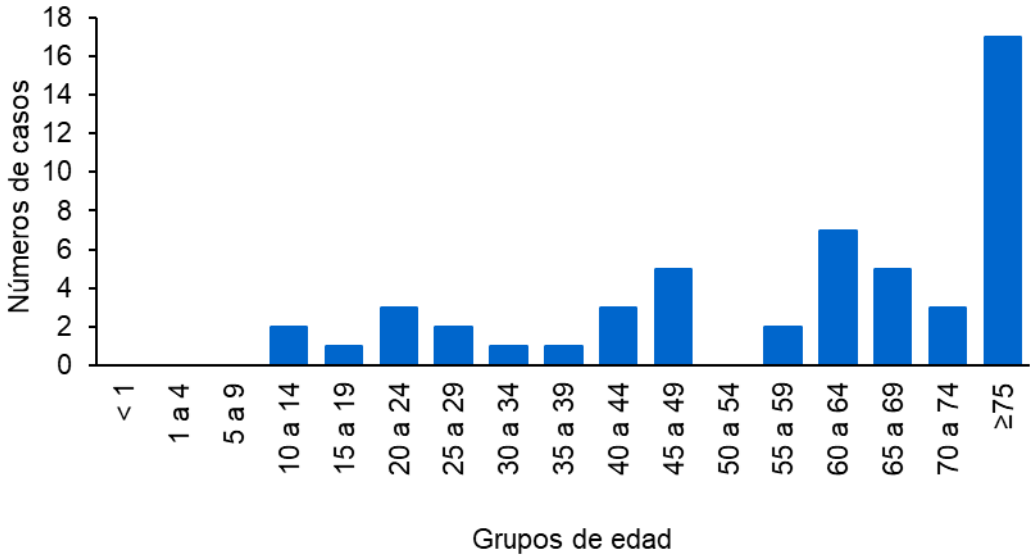
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 52 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (24/52) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (25/52).

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 27, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 27, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 35 casos notificados con una tasa de 1,3 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 17 casos notificados con una tasa de 0,6 por 100.000 habitantes.

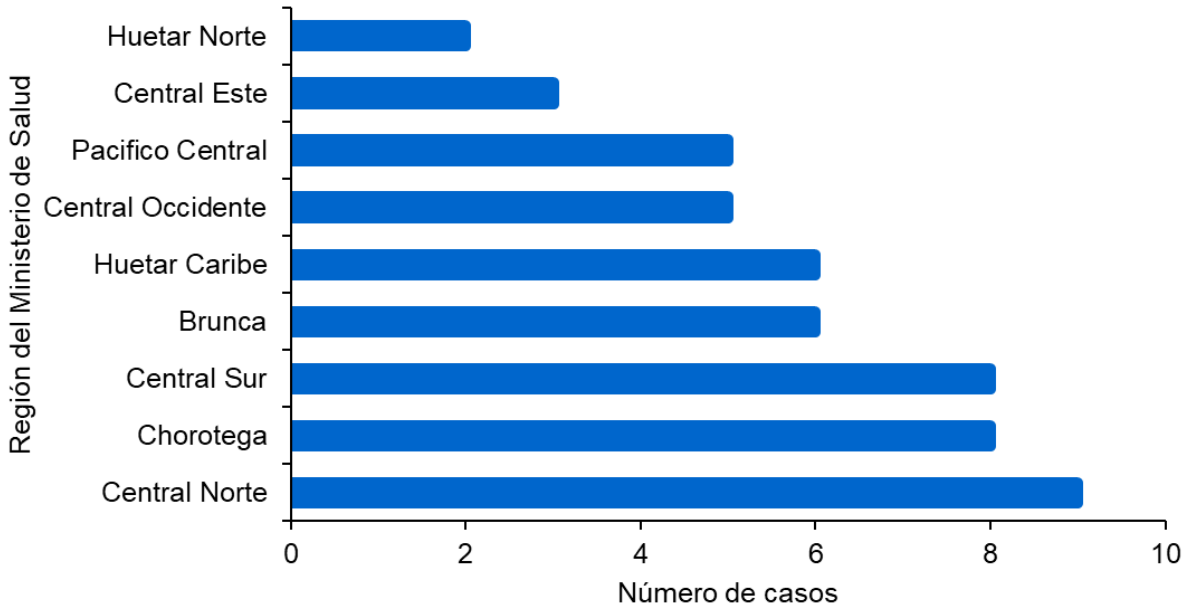
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 27, 2025

Provincias	Casos	Tasas
Total	**52**	**1,0**
San José	9	0,5
Alajuela	12	1,1
Cartago	3	0,5
Heredia	5	0,9
Guanacaste	8	1,9
Puntarenas	9	1,7
Limón	6	1,2

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la SE 27, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (12/52) seguido por la provincia de San José (9/52) y Puntarenas (9/52).

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 27, 2025

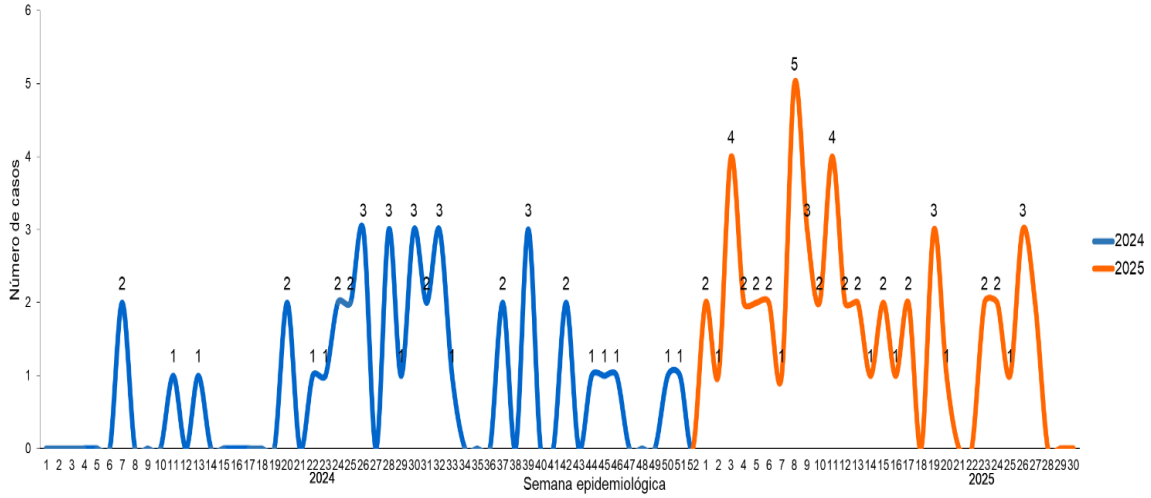


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (9/52) la que presenta el mayor número de casos.

Gráfico 4

Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, año 2024 al corte de la SE 27 del 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

Cuadro 2

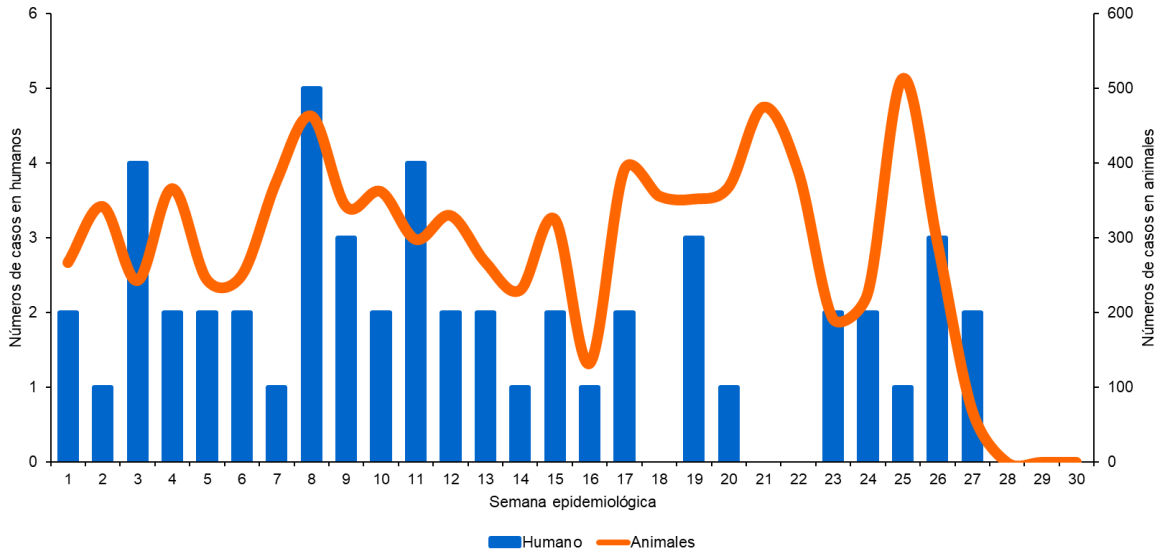
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador a la SE 27 del 2024 y 2025

SE	Número de casos	
	2024	2025
1	0	2
2	0	1
3	0	4
4	0	2
5	0	2
6	0	2
7	2	1
8	0	5
9	0	3
10	0	2
11	1	4
12	0	2
13	1	2
14	0	1
15	0	2
16	0	1
17	0	2
18	0	0
19	0	3
20	2	1
21	0	0
22	1	0
23	1	2
24	2	2
25	2	1
26	3	3
27	0	2
Total	**15**	**52**

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 27 del 2025 y en el cuadro 2 el comportamiento de los casos de la SE 01 a 27 del 2024 y SE 01 a 27 del 2025, observando un aumento significativo de los casos durante la SE 08 del 2025, con un total de 52 casos confirmados por esta enfermedad, siendo que para la SE 27 del 2024 se confirmaron 15 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Gráfico 5
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales según SE de la 01 a la 27, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 05 de julio del 2025, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 5, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en humanos y animales por SE de la 01 a la 27 del 2025, con 52 casos confirmados en humanos y 8465 casos confirmados en animales (datos preliminares en animales sujetos a cambio).

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una**

Sola Salud, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Servicio Nacional de Salud Animal-Ministerio de Ambiente y Energía según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales que puedan ser atendidos de manera oportuna.
A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna

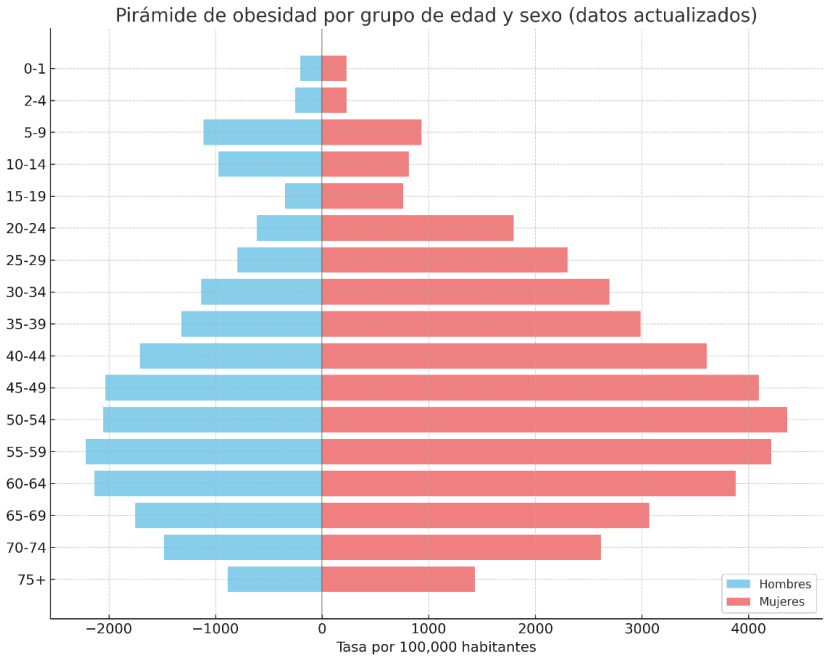
Incidencia De Obesidad en Costa Rica. 2024

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

Análisis Descriptivo De Los Datos Notificados
Distribución Por Grupo Etario y Sexo

La pirámide de obesidad muestra la distribución de las tasas de obesidad por cada 100.000 habitantes, según grupo de edad y sexo, a partir de datos de notificación obligatoria.

Gráfico 1.
Costa Rica. Pirámide de Obesidad por grupo de edad y sexo según incidencia 2024



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

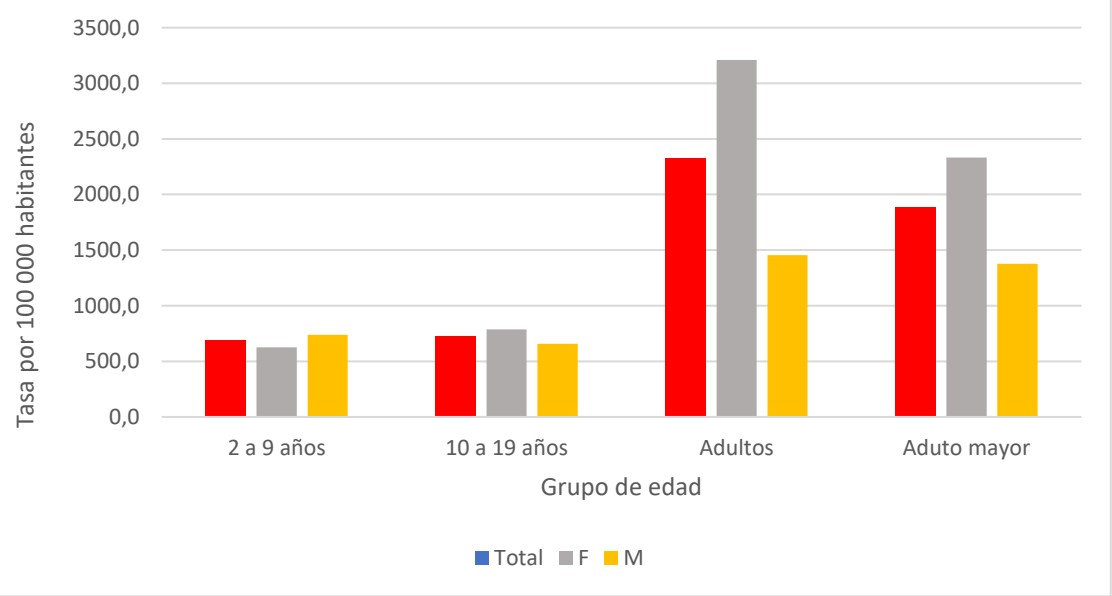
Tendencia por edad:

Las tasas de obesidad aumentan progresivamente desde la adolescencia, alcanzando su punto máximo entre los 50 a 59 años, con una disminución posterior en los adultos mayores.

Al analizar los datos por curso de vida la obesidad sigue siendo un problema prioritario en población adulta y adulta mayor, especialmente en mujeres.

El grupo adulto (20 a 59 años) representa el mayor peso en la carga de obesidad, con el 78,9% de los casos notificados y la tasa más alta (2.324,4). Le sigue el adulto mayor, con una tasa de 1.883,2, siendo también alta y en los menores de edad (2 a 19 años), las tasas son menores, pero no despreciables: 683,8 (niños) y 721,2 (adolescentes).

Gráfico 2.
Costa Rica. Casos notificados de Obesidad por grupo de edad. 2024



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

Diferencias por sexo:

Los datos de notificación obligatoria muestran una alta carga de obesidad en mujeres adultas de mediana edad, reflejando una doble carga de la obesidad notificada en mujeres en relación con los hombres.

Las mujeres presentan tasas consistentemente más altas en todos los grupos de edad a partir de los 20 años, especialmente entre los 40 y 59 años. En cambio, en

los grupos de 2 a 9 años, los hombres presentan mayores tasas que las mujeres, lo que podría indicar una alerta para intervenciones tempranas.
La diferencia de tasas entre mujeres y hombres entre los 50-54 años es +2.307 casos por 100 00 habitantes. La máxima tasa en mujeres está en el grupo de 50-54 años, mientras que, en hombres de 5 a 59 años, aunque bastante menor que en mujeres. Si bien en la infancia las tasas son menores (La menor tasa está en niños de 2 a 4 años (196.5)), preocupa el aumento progresivo a partir de los 15 años hasta los 59, luego baja en mayores de 65 años.

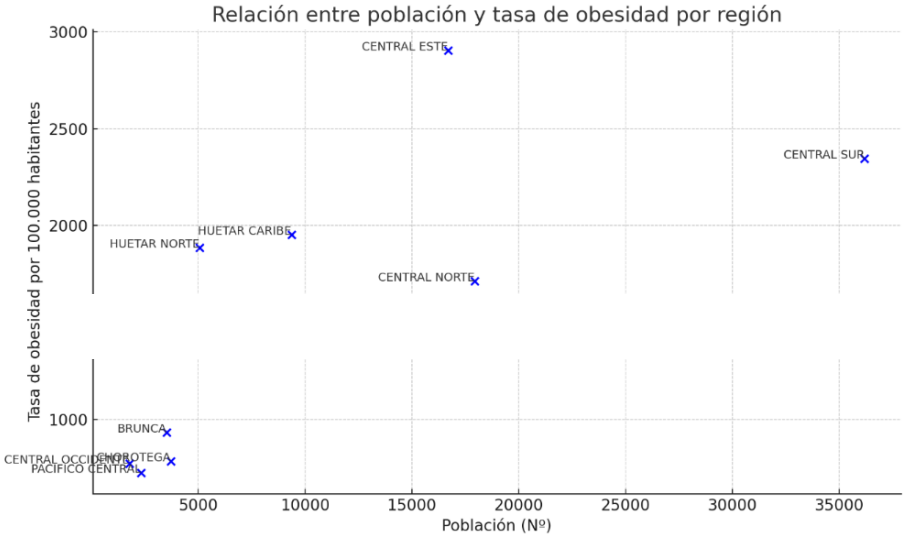
Razón de prevalencia

La razón de prevalencia es de 1.98 mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres presentan una prevalencia de obesidad de 1,98 veces mayor que los hombres en la población analizada.

Distribución por Región de Salud

Para el análisis adecuado de los datos se utilizan tasas estandarizadas por 100 000 habitantes lo que permite enfocar acciones en proporción al riesgo y no solo valorara el volumen de casos, entonces una región con muchos casos puede tener una tasa baja si la población es alta o viceversa.

Gráfico 3.
Costa Rica. Relación entre población y tasa de obesidad por Región rectora de Salud. 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

El gráfico muestra que no existe una relación lineal clara entre el número de casos reportados y la tasa de obesidad. Por ejemplo, la región Central Este tiene una alta tasa con una población intermedia, mientras que Central Sur, con mayor cantidad de casos, presenta una tasa más moderada. Esto resalta la importancia de considerar tanto la magnitud como la proporcionalidad (tasas) para priorizar intervenciones de salud pública.

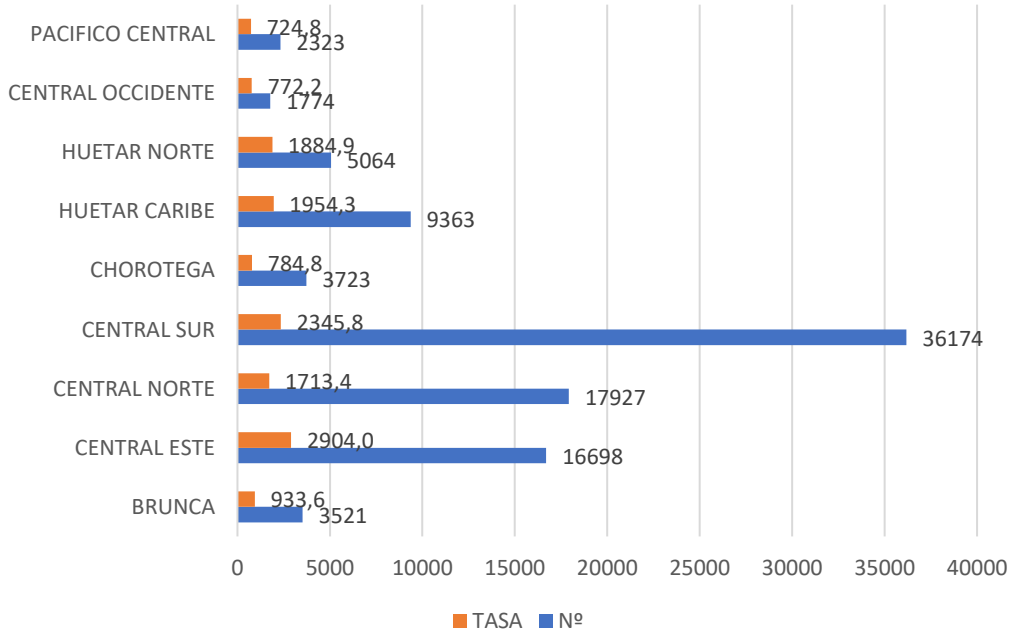
Algunos hallazgos detectados con base a los datos notificados son:

Central Este y Central Sur presentan tasas de obesidad elevadas, incluso con poblaciones grandes.

Algunas regiones como Huetar Caribe y Huetar Norte tienen tasas altas pese a poblaciones intermedias.

Pacífico Central y Central Occidente tienen tasas bajas con poblaciones pequeñas, lo cual podría ser esperado.

Gráfico 4.
Costa Rica. Casos notificados de Obesidad según región rectora de salud, 2024



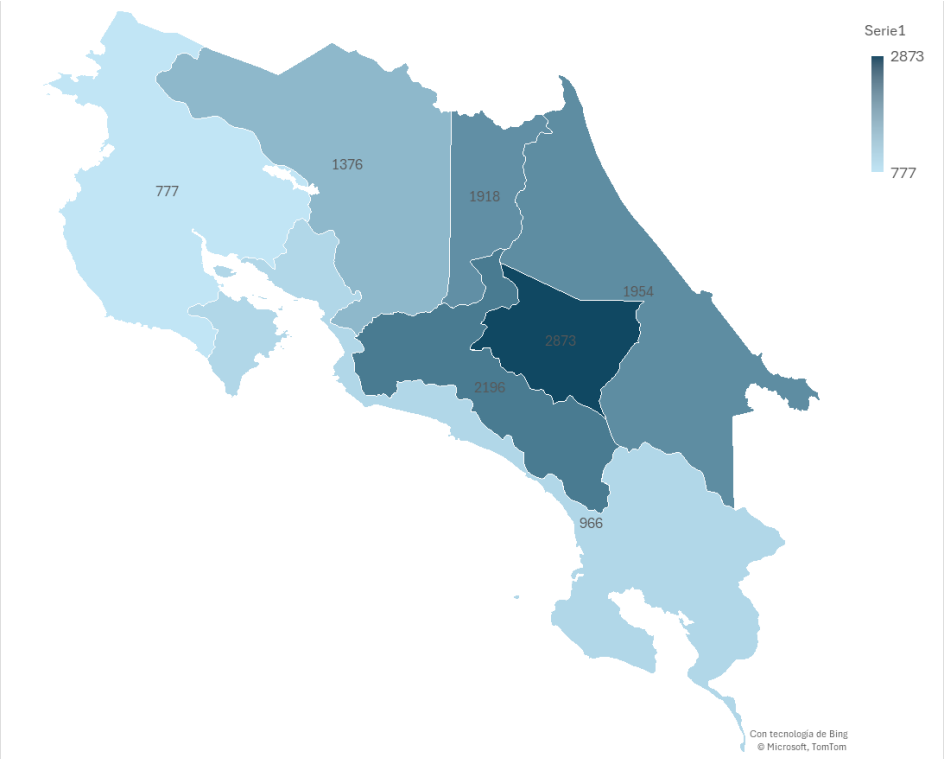
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

Las regiones Central Este, Central Sur y Huetar Caribe presentan las tasas más altas de obesidad notificadas, lo que indica mayor carga relativa de enfermedad. Este patrón en la GAM podría estar vinculado con factores urbanísticos, acceso a alimentos ultraprocesados y estilos de vida sedentarios. Se recomienda priorizar intervenciones regionales diferenciadas, con énfasis en promoción de la salud, vigilancia nutricional y control de ambientes obesogénicos.

Distribución por Provincia

La provincia con mayor tasa de obesidad es Cartago, seguido de tasas altas en San José y Limón esto muestran que esas provincias cuentas con sistemas de salud más eficientes en la capacidad diagnóstica del evento demostrado en la notificación mayor. Las provincias con tasas medias son Heredia y Alajuela y las menores tasas se reflejan en Guanacaste y Puntarenas, zonas costeras que posiblemente presentan menor acceso a servicios de salud, además de un estilo de vida rural más activo.

Figura 1.
Costa Rica. Incidencia de Obesidad por provincia. 2024



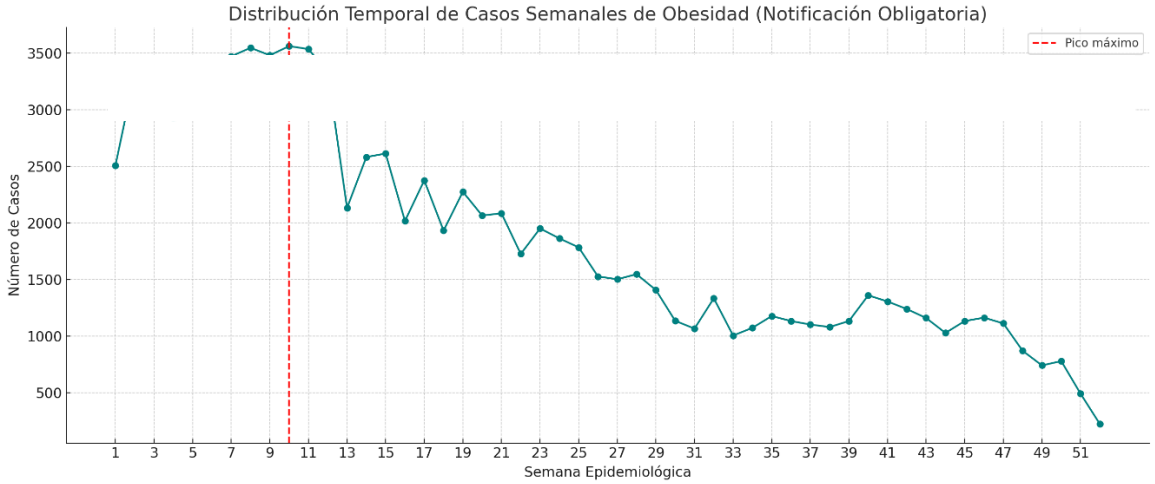
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

La distribución general por cantones muestra que la mayoría tienen tasas de obesidad entre aproximadamente 700 y 3000 por cada 100,000 habitantes. La mediana se sitúa alrededor de 1,400–1,800.
Los siguientes cantones presentan tasas extremadamente elevadas, lo que indica una alta carga de obesidad en la población y posiblemente un mejor sistema de notificación de casos.: San Pablo y Barva de Heredia, Dota en San José, La Unión y Paraíso en Cartago, Moravia y Aserrí en San José, y Grecia en Alajuela.
En Heredia y Cartago, varias tasas superan los 4000 por 100.000 habitantes, lo que sugiere focos prioritarios para intervención.
Algunos cantones reportan tasas sorprendentemente bajas, lo cual puede indicar posible subregistro o limitado acceso a atención médica entre ellos Tilarán y Carrillo de Guanacaste, Quepos y Esparza en Puntarenas, San Mateo en Alajuela y Flores y Belén en Heredia.
Cartago, San José, Heredia y Alajuela: presentan varios cantones con tasas elevadas. Esto sugiere que la obesidad tiene una mayor carga en zonas más urbanas y con mayor densidad poblacional.
Guanacaste y Puntarenas: tienen una mayor concentración de tasas bajas, lo que podría deberse a estilos de vida más activos, pero también podría esconder un subregistro en los datos.

Distribución Temporal de Casos

La distribución temporal de casos notificados por semana epidemiológica (SE) muestra un patrón de alta notificación a inicios de año y una disminución sostenida a partir de la SE 13 donde se observa que los casos descienden de forma paulatina, en comparación con las semanas anteriores. La SE 13 en el 2024 correspondió a semana santa (24 al 31 de marzo del 2024), posterior a esta semana se refleja menor prioridad diagnostica de este evento.
Existen patrones de notificación marcados que coinciden con menor asistencia a servicios de salud y cierres institucionales entre ellos semana santa, vacaciones de julio donde se observa una segunda caída con una notificación de casos con niveles inferiores al promedio y finalmente el nivel mínimo de notificación en la SE 52 acorde con las celebraciones festivas y periodos de vacaciones.
Se destaca que la baja de casos durante las vacaciones y Semana Santa no indica que disminuya la obesidad, sino que existe una menor detección y reporte, o interrupciones en las actividades de vigilancia.

Gráfico 5.
Costa Rica: Casos notificados de Obesidad según semana epidemiológica. 2024



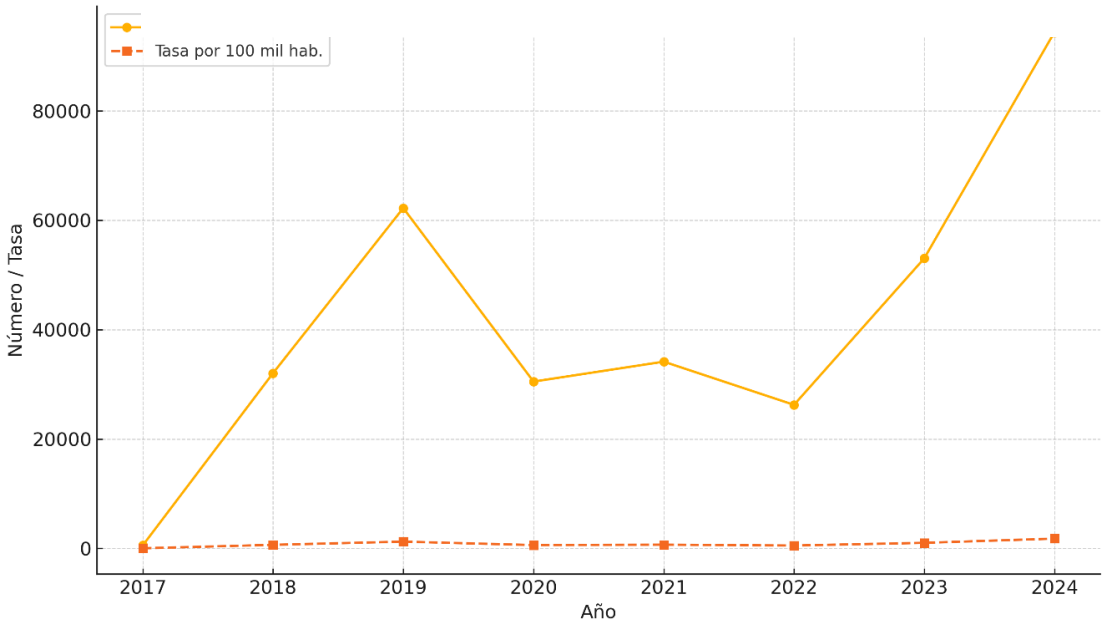
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

Se observa una alta incidencia en el primer trimestre del año (semanas 1 a 12), donde el pico máximo ocurre en la SE 10 con 3563 casos notificados seguido de un descenso progresivo. Desde la semana 30 en adelante, los casos se estabilizan en niveles bajos y decrecientes registrando el mínimo de casos en la SE 52 con solo 224 casos.

Comparación con Años Anteriores

La tendencia multianual refleja el impacto de eventos externos como la pandemia de COVID-19 (2020-2021) y el hackeo informático de la CCSS (2022). La caída entre 2020–2022 no debe interpretarse como una reducción real de casos, sino como una disminución en la capacidad del sistema para captarlos.
En contraste, el aumento de 2023–2024 probablemente representa una combinación de mejoras en el sistema de registro y un aumento real de la carga de enfermedad, lo cual refuerza la urgencia de intervenciones intersectoriales sostenidas.

Gráfico 6.
Costa Rica. Tendencia Multianual de casos notificados de obesidad 2017-2024



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Bases de notificación obligatoria VE01.

El grafico anterior obedece a:
2017. Primer año de notificación obligatoria del evento de Obesidad
2017–2019: Se observa una tendencia creciente en la notificación de casos de obesidad, reflejando mejoras en el sistema de vigilancia y mayor concientización del personal de salud.
2020–2021: La priorización de la pandemia por COVID-19 provocó una caída considerable en la notificación, ya que los recursos y el personal se reasignaron al manejo de emergencias sanitarias. Las consultas de seguimiento para condiciones crónicas se redujeron, afectando la captación de casos de obesidad.
2022: El ciberataque a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) interrumpió múltiples sistemas clínicos y de información, lo que provocó una infra-notificación significativa durante varios meses del año.
2023–2024: Se observa una recuperación progresiva, con un aumento especialmente marcado en 2024. Esto puede asociarse a:
Restauración completa de los sistemas de información clínica.
Mayor capacitación en el llenado de formularios de notificación obligatoria.
Posible aumento real de la incidencia de obesidad como efecto postpandemia.

Mortalidad

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Costa Rica reporta los datos preliminares de mortalidad obtenidos a través de las estadísticas vitales.
Para el 2024 se notificó en total 119 fallecidos con diagnostico principal de Obesidad, desglosados en:
Obesidad no especificada (E669) representó el 53% del total de muertes por obesidad, lo cual puede reflejar limitaciones en la codificación clínica o diagnóstica.
Otros tipos de obesidad (E668) son responsables del 44.5% de los casos, mostrando también una alta carga.
La obesidad extrema con hipoventilación alveolar (E662), aunque menos frecuente (2.5%), está asociada a una condición grave y específica.
Se observa que el 56% de las defunciones atribuibles a obesidad se presentan en hombres, lo cual contrasta con la mayor prevalencia de esta condición en mujeres, quienes presentan una razón de prevalencia de 1,98 en comparación con los hombres.
Esta diferencia podría explicarse por una mayor proporción de obesidad severa en los hombres o por una menor atención médica oportuna en esta población, lo que incrementaría su riesgo de mortalidad a pesar de tener una menor incidencia general.
Aunque la obesidad representa solo el 4,3% de las muertes clasificadas directamente dentro del grupo E00–E89 DE Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, es importante reconocer que muchas muertes en este grupo pueden estar indirectamente influenciadas por la obesidad (como diabetes tipo 2, dislipidemias, hipotiroidismo, etc.).
El 74% de las muertes por enfermedades endocrinas y metabólicas ocurre en adultos mayores.
Sin embargo, 1 de cada 4 muertes ocurre en población en edad productiva (15–64 años), lo que indica una pérdida importante de años de vida saludable, y que puede vincularse a obesidad no controlada y sus complicaciones.

Conclusiones y Recomendaciones

La obesidad continúa siendo un evento de alta notificación y un problema de salud pública en el país, es necesaria una estrategia diferenciada por edad y sexo,
Las políticas deben enfocarse en prevención temprana, educación nutricional y atención focalizada en mujeres adultas, además deben contemplar intervenciones tempranas en niños y adolescentes, para evitar progresión hacia la adultez.
Se recomienda fortalecer el sistema de vigilancia nutricional para:
reforzar acciones de prevención en regiones con mayor carga de casos, especialmente en grupos etarios vulnerables.
supervisar la notificación en provincias con tasas bajas a través de las Áreas Rectoras de Salud, para descartar subregistro.
supervisar el sistema de vigilancia en cantones con tasas menor a 300 casos, para detectar posibles fallas en el registro.
Es indispensable tomar en cuenta las disminuciones en la notificación durante los periodos vacacionales para ajustar la comunicación y el análisis de datos.
Se insta a priorizar intervenciones en cantones con tasas mayor a 3000 casos, especialmente San Pablo, Barva, La Unión, Dota.
Es conveniente fortalecer acciones intersectoriales (salud, educación, gobiernos locales) en zonas urbanas con mayores tasas.
Se propone desarrollar campañas educativas diferenciadas por región, atendiendo a las realidades culturales y socioeconómicas locales.

Bibliografía

Federación Mundial de Obesidad. (2025). *World Obesity Atlas 2025*. https://www.worldobesity.org/atlas2025
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2023). *Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe 2023*. https://www.fao.org/americas/publicaciones